EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	Nº EGRESO	:	66702
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2023-07-01 09:57:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CARLOS ORLANDO FERNANDEZ PLAZA			RUN	: 5.421.597-5
F.Nac	: 04-04-1949	Edad	: 74 AÑOS, 2 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: SEPTIMA AVENIDA 1261			Comuna	: SAN MIGUEL
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-06-29	Fecha Egreso	: 2023-07-01 09:57:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico paramediano pontino derecho 2° ATE 1/3 medio AB
-Sd motor FBC izquierdo
-Web ACI cervical derecha

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. M15-M19-ARTROSIS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Historia clínica
Paciente previamente en su basal, niega sintomas previos sistémicos o constitucionales, presentó el 25/6/23 a las 15.00h un episodio súbito de disestesias generalizadas que duraron aprox 2 min, luego disartria y paresia leve a moderada FBC izq que dificultada pero no impedía la marcha, no asociado a otra focalidad neurológica ni síntomas cardiopulmonares. Consulta en SU HSC, PA176/77, T 36.6, HGT 100, exs lab sin hallazgos significativos, ECG RS, TC cerebro mostró lesión isquémica que impresiona no aguda frontal cortical derecha sin TH, en angioTC cerebro y cuello se observa estenosis 1/3 medio AB >50%, web ACI cervical derecha y posible estenosis +- 50% en origen de arteria subclavia (web?) con dilatación focal postenótica. Se hospitaliza para evaluacion y manejo.
Paciente se mantiene en BEG, HDN con HTA en regresión progresiva, eupneico, afebril, el 27/6 sufre deterioro neurologico significativo, con hemiplejia BC izquierda, no asociada a otros síntomas/signos focales neurológicos, que se mantiene hasta la evaluación de hoy (29/6/23). Impresiona que progresión se debe a lesión isquémica paramediana pontina 2° a ATE 1/3 AB (enf vaso parental), no visible inicialmente. Mantiene RS al monitor y ECG, tolera bien alimentación VO. Solicito nuevo angioTC para definir origen de deterioro 2° (aparentemente sin alteracion HDN, infecciosa o metabolica que lo explique).

Evolución
Paciente se mantiene en BEG, HDN estable, eupneico, afebril, RS al monitor, sin arritmias registradas en las últimas 24h, mantiene hemiplejia BC izquierda y disartria de caracter nasal sin cambios, no refiere otras molestias, tolera bien alimentación VO. AngioTC cerebro y cuello de control muestra infarto paramediano pontino derecho establecido, no visible en exs previos, vasos arteriales y venosos sin cambios, sin TH.
Hoy se intala Holter de ritmo y se toma ETT.
En vista de la estabilidad clínica por 72h se decide inicio de DAPT sin carga por ATE intracraneana sintomática con progresión completa, alta a domicilio el 1/7/23 posterior a retiro de Holter de ritmo, rehabilitación por HODOM y control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-12 días.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio el 1/7/23 posterior a retiro de Holter de ritmo
-Rehabilitación por HODOM
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-12 día

INDICACIONES AL ALTA

1. -Aspirina 100 mg/d
2. -Clopidogrel 75 mg/d
3. -Atorvastatina (40 mg) 2 comp/noche
4. -Famotidina 40 mg/d
5. -Losartan (50 mg) 1/2 comp c/12h

EXÁMENES Y RESULTADOS

29/6/23
-Alb 4.5
-Crea 0.8 MDRD 94.5 Uremia 35
-AU 5
-Ca 9.3 Na 140 K 4.3 Cl 103
-FA 75 BI 0.6 BD 0.04 BT 0.64 GOT 21 GPT 19 GGT 18
-Lact 2
-PCR <5
-Leu 6500 Hb 13.6 Plaq 278000Seg 62
-VHS 15
-INR 1.13
-B12 383
-RPR N/R

25/6/23
-Glic 99
-Crea 0.8 MDRD 94.5 Uremia 43
-AU 4.5
-Ca 9.3 Na 141 K 4.7 Cl 105
-FA 82 BI 0.39 BD 0.01 BT 0.4 GOT 15 GPT 16 GGT 17
-ColT 173 HDL 43 LDL 107 VLDL 24.8 TG 124
-LDH 131
-Lact 1.7
-Hb 12 Leu 5900 Plaq 236000 Seg 59
-INR 1.07 TTPA 30
-TSH 1.871 T4L 1.02
-Hb glic 4.9

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurologico:
-Mental: vigil, OTE, atención N, lenguaje N, gnosias N
-PC: CV conservado, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC izq leve, disartria leve a moderada, sens facial N, nistagmo(-), úvula central, elevación palatina simétrica, fuerza ECM M5, fuerza trapecios M5 derecho y M0 izq
-Motor: BC derecho M5, BC M0-1 (logra leve flexión crural al dolor), RCP extensor izquierdo y flexor derecho
-Sensitivo: conservado multimodal
-Cerebelo: conservado a derecha, n/e a izq por paresia
-Signos meningeos(-)

CAMILA COLLAO ITURRA
MEDICO TRATANTE
19088566-6

JEFE SERVICIO